

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA SOBERANÍA SANITARIA DE COLOMBIA

ANEXO 8. ORIENTACIONES EXPERIENCIA MÍNIMA.

A continuación se presenta el anexo que contiene las orientaciones sobre la experiencia mínima habilitante para la presente convocatoria. La experiencia mínima corresponde al requisito obligatorio que deben cumplir la alianza, para lo cual deberán acreditar al menos tres (3) proyectos de I+D+i en ejecución o ejecutados en los últimos diez (10) años relacionados con la línea temática a la que se postulan, conforme a lo establecido en este anexo. En este sentido, para cada línea temática se especifican de manera detallada los criterios de experiencia mínima.

Nota: La experiencia mínima de la alianza es un requisito obligatorio que debe cumplirse para poder presentar la propuesta, pero no otorga puntaje, ni se utiliza para definir desempates o el orden del banco de elegibles. Si la alianza no acredita esta experiencia, la propuesta será rechazada.

1. Fortalecimiento de la cadena de valor de producción de tecnologías estratégicas en salud: Proyectos de I+D+i orientados al fortalecimiento de las capacidades nacionales para la producción de medicamentos y tecnologías en salud, con el fin de contribuir a la soberanía sanitaria y al acceso oportuno, equitativo y sostenible a tecnologías estratégicas en Colombia.

Las propuestas deben abordar, de manera específica al menos uno de los siguientes componentes:

a. Producción nacional de insumos farmacéuticos, incluyendo principios activos, excipientes e insumos críticos, mediante el desarrollo de procesos productivos, escalamiento industrial y cumplimiento normativo.

b. Diseño, desarrollo, validación y escalamiento de tecnologías en salud, tales como medicamentos, vacunas, biológicos, reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias, incluyendo el aprovechamiento de tecnologías disponibles en el dominio público.

c. Fortalecimiento de capacidades de investigación biomédica, sistemas de calidad, bioseguridad y bienestar animal en bioterios, así como el desarrollo y validación de métodos alternativos al uso de animales en investigación.

d. Fortalecimiento de capacidades institucionales para entidades que tengan interés en desarrollar, fortalecer o articular capacidades científicas, tecnológicas, regulatorias, de calidad, validación, transferencia de conocimiento, asistencia técnica o apropiación tecnológica en salud orientadas a la futura participación en la cadena de producción de tecnologías estratégicas en salud. Estos proyectos podrán enmarcarse en niveles tempranos o intermedios de madurez tecnológica (TRL 1 a 5), abarcando desde actividades de investigación básica y formulación de conceptos (TRL 1-3), hasta procesos de validación experimental a nivel de laboratorio o en entornos relevantes (TRL 4-5), mediante acciones de formación, transferencia de conocimiento, asistencia técnica o articulación



con actores del sector, que permitan sentar las bases para su vinculación progresiva al ecosistema de I+D+i en salud.

Investigación (I): generación de conocimiento científico en desarrollo farmacéutico, biotecnología, procesos productivos, biología molecular y métodos alternativos.

Desarrollo (D): diseño y validación de procesos productivos, escalamiento industrial, desarrollo de prototipos de medicamentos, vacunas o dispositivos y transferencia tecnológica. De igual manera mejoramiento del sistema de calidad para el bienestar animal.

Innovación (i): producción local de tecnologías en salud o mejoramiento de sistemas de entrega de tecnologías existentes.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i relacionados con biología, química, química farmacéutica u otras áreas afines, así como en el sector salud, farmacéutico y/o de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico.

2. Investigación intersectorial con enfoque de Una Salud (One Health) para la vigilancia, prevención y control de la resistencia antimicrobiana: Proyectos de I+D+i de carácter intersectorial e interdisciplinario orientados a fortalecer las capacidades nacionales para la generación de conocimiento, y el desarrollo tecnológico y la implementación de soluciones innovadoras dirigidas a la vigilancia, prevención y control de la resistencia antimicrobiana (RAM) en Colombia.

Estos proyectos deberán adoptar el enfoque de Una Salud (One Health), reconociendo la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, y promoviendo la articulación efectiva entre sectores como salud, agricultura, ambiente, academia e industria.

Los proyectos tendrán que abordar el fortalecimiento de sistemas de vigilancia integrados, estrategias para el uso racional de antimicrobianos, desarrollo de herramientas diagnósticas y generación de evidencia para la toma de decisiones en salud pública.

Investigación (I): estudios epidemiológicos, microbiológicos y ambientales sobre la detección de incidencia y transmisión de resistencia antimicrobiana.

Desarrollo (D): creación de sistemas integrados de vigilancia, herramientas diagnósticas o modelos predictivos y herramientas de detección ambiental de contaminantes que conlleven a resistencia antimicrobiana.

Innovación (i): desarrollo, implementación y evaluación de estrategias para el uso racional de antimicrobianos y la mitigación de la resistencia antimicrobiana (RAM), incluyendo la adopción de nuevas tecnologías, herramientas diagnósticas, plataformas de vigilancia integrada, soluciones basadas en analítica de datos e innovaciones aplicadas, con enfoque territorial y de sostenibilidad.

Experiencia Mínima:

Av. Calle 26 # 57- 41 / 83 Torre 8 Piso 2 – PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C. Colombia

- Experiencia en proyectos de I+D+i relacionados con resistencia antimicrobiana, o en temáticas afines como microbiología, enfermedades infecciosas, salud pública, salud animal o ambiental.

3. Investigación en trabajos de cuidado, economía del cuidado y salud mental: Proyectos de I+D+i orientados a la generación de evidencia y al diseño, implementación y evaluación de modelos, políticas e innovaciones sociales en salud que reconozcan, valoren, redistribuyan y fortalezcan los trabajos de cuidado en Colombia. Estas iniciativas deberán incorporar de manera explícita el enfoque de género, de derechos y de determinantes sociales en salud, con especial énfasis en las implicaciones del cuidado sobre la salud mental y el bienestar de las personas cuidadoras y receptoras de cuidado, así como en su articulación efectiva con el sistema de salud, la atención en salud mental y los sistemas de protección social.

Investigación (I): Generación de conocimiento y evidencia sobre los trabajos de cuidado, su relación con los determinantes sociales en salud y su articulación con los sistemas de salud, salud mental y protección social. Incluye estudios cualitativos y cuantitativos, análisis de políticas, caracterización de poblaciones cuidadoras y evaluación de necesidades, brechas y desigualdades asociadas al cuidado, con énfasis en los efectos del trabajo de cuidado sobre la salud mental de quienes cuidan incluyendo carga emocional, agotamiento, trastornos del estado de ánimo y barreras de acceso a servicios de salud mental, así como en las necesidades de salud mental de las poblaciones que reciben cuidado.

Desarrollo (D): Diseño y adaptación de modelos, estrategias, herramientas e intervenciones que reconozcan, valoren y fortalezcan los trabajos de cuidado, incorporando la dimensión de salud mental como eje estructurante. Este componente comprende la estructuración de pilotos, lineamientos técnicos, rutas de atención integral que incluyan componentes psicosociales y de salud mental, y mecanismos de articulación intersectorial con el sistema de salud, los servicios de salud mental y la protección social, orientados a reducir la carga mental y emocional asociada al cuidado y a fortalecer el bienestar de las personas cuidadoras.

Innovación (i): implementación, validación y escalamiento de innovaciones sociales y tecnológicas para transformar los trabajos de cuidado, promoviendo su reconocimiento, redistribución y sostenibilidad. Incluye el uso de inteligencia artificial, analítica de datos y soluciones digitales para optimizar la gestión del cuidado, con énfasis en la protección de la salud mental de personas cuidadoras y cuidadas, así como la evaluación de impacto y el desarrollo de soluciones replicables que incidan en políticas públicas con enfoque territorial, diferencial y de género.

Experiencia mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en economía del cuidado, salud mental, o áreas afines relacionadas con cuidado.

4. Investigación en el diseño, evaluación y fortalecimiento de modelos integrales de atención en salud para la persona mayor: Proyectos de I+D+i orientados al diseño, evaluación y fortalecimiento de modelos integrales de atención en salud en Colombia centrados en la persona mayor, que incorporen el enfoque de curso de vida, envejecimiento saludable y activo, continuidad del cuidado, atención primaria y articulación intersectorial. Estas iniciativas deberán contribuir a

mejorar la calidad de vida, la autonomía funcional y la participación social de las personas mayores, reconociendo la heterogeneidad del envejecimiento y las inequidades asociadas.

Investigación (I): Generación de evidencia orientada a comprender las necesidades, condiciones de salud y trayectorias de vida de las personas mayores. Incluye la evaluación de modelos existentes de atención integral, el análisis de su efectividad, calidad, accesibilidad y continuidad del cuidado, así como estudios sobre la articulación entre sectores y niveles de atención, particularmente en el marco de la atención primaria en salud.

Desarrollo (D): Diseño y fortalecimiento de modelos integrales de atención centrados en la persona mayor, incorporando el enfoque de curso de vida, envejecimiento activo y continuidad del cuidado. Este componente contempla la construcción de rutas de atención, protocolos, herramientas de gestión y mecanismos de articulación intersectorial que permitan operativizar dichos modelos en los sistemas de salud y protección social.

Innovación (i): implementación, validación y escalamiento de soluciones orientadas a optimizar la atención integral de las personas mayores. Incluye el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y analítica de datos para mejorar la gestión del cuidado y la toma de decisiones, así como el desarrollo de experiencias piloto y la evaluación de impacto de los modelos implementados. Se espera la generación de soluciones escalables y replicables que contribuyan a la transformación de los servicios de salud y al fortalecimiento de la articulación intersectorial, con enfoque territorial, diferencial y de curso de vida.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en investigación en envejecimiento o salud de la persona mayor o modelos de atención en salud.

5. Eliminación y sostenimiento de la eliminación de enfermedades transmisibles y condiciones prioritarias: Proyecto de I+D+i orientados al diseño, implementación y evaluación de estrategias innovadoras que fortalezcan la vigilancia en salud pública, la investigación de la implementación y la Atención Primaria en Salud, con el propósito de contribuir a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el control, la eliminación y el sostenimiento de la eliminación de enfermedades transmisibles priorizadas en el país.

Estas iniciativas deberán articularse con las prioridades nacionales en salud pública, los sistemas de información en salud y los modelos de atención vigentes, promoviendo enfoques territoriales, diferenciales e intersectoriales que respondan a las particularidades epidemiológicas y sociales de Colombia.

Los proyectos deberán alinearse con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Eliminación de Enfermedades Transmisibles (PNEET) e incorporar enfoques diferenciales, territoriales e interculturales.

Investigación (I): estudios epidemiológicos y de implementación sobre enfermedades transmisibles con énfasis en nuevos esquemas terapéuticos y nuevas tecnologías para el diagnóstico en humanos y el manejo integrado de vectores.

Desarrollo (D): diseño de estrategias de vigilancia, modelos comunitarios de prevención a través de intervenciones que aporten a las metas e hitos del PNEET.

Innovación (i): aplicación de nuevas herramientas digitales, inteligencia artificial y analítica de datos, articuladas con intervenciones territoriales, para impulsar respuestas tempranas, integrales y basadas en evidencia frente a las prioridades del PNEET, fortaleciendo la toma de decisiones, la vigilancia y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en enfermedades transmisibles o enfermedades desatendidas o enfermedades transmitidas por vectores.

6. Investigación en enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer: Proyectos de I+D+i orientados a generar evidencia, el desarrollo de soluciones y la implementación de estrategias integrales para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la detección temprana, la atención integral y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en Colombia. Se priorizarán aquellas que generan mayor carga de enfermedad y mortalidad en el país, incluyendo el cáncer, las enfermedades cardio metabólicas, las enfermedades respiratorias crónicas, así como las alteraciones en salud bucal, visual y auditiva.

Los proyectos deberán incorporar enfoques de curso de vida, determinantes sociales de la salud, equidad, género e interculturalidad, y articularse con la Atención Primaria en Salud (APS) y los modelos de gestión del riesgo en salud.

Investigación (I): estudios clínicos, epidemiológicos y de determinantes sociales de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Desarrollo (D): diseño de intervenciones preventivas, modelos de atención y/o tecnologías digitales de seguimiento y control de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Innovación (i): implementación, evaluación y escalamiento de estrategias poblacionales y modelos de gestión del riesgo, incorporando herramientas digitales y soluciones basadas en datos para mejorar la oportunidad, calidad y continuidad de la atención en el sistema de salud.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en enfermedades crónicas no transmisibles o cáncer.

7. Fortalecimiento para la detección temprana y la atención integral en enfermedades huérfanas/raras: Proyectos de I+D+i en Colombia orientados al diseño, implementación y evaluación de estrategias que fortalezcan la detección temprana, diagnóstico oportuno, la atención integral y la gestión del riesgo en enfermedades huérfanas o raras (EHR). Estas iniciativas deberán contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir los tiempos diagnósticos, optimizar las rutas de atención y disminuir las inequidades en el acceso a servicios de salud.



Los proyectos deberán articularse con la Atención Primaria en Salud (APS), los sistemas de vigilancia y los modelos de gestión del riesgo, incorporando enfoques diferenciales, de curso de vida y de derechos.

Los proyectos tendrán que incorporar herramientas digitales, analítica de datos e inteligencia artificial, así como el desarrollo para mejorar la atención de estas condiciones.

Investigación (I): estudios genéticos, epidemiológicos y clínicos.

Desarrollo (D): diseño de herramientas diagnósticas y modelos de atención.

Innovación (i): implementación, evaluación y escalamiento de soluciones tecnológicas y modelos integrales de atención, incorporando inteligencia artificial, analítica de datos y sistemas digitales para mejorar la detección temprana, la oportunidad diagnóstica, la continuidad del cuidado y la toma de decisiones en el sistema de salud.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en enfermedades huérfanas o raras (EHR) o genética.

8. Fortalecimiento de la evidencia para la reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas: Proyectos de I+D+i en Colombia orientados a la generación de evidencia y el diseño, implementación y evaluación de estrategias de reducción de riesgos y daños (RRD) asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Estas iniciativas deberán contribuir a la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas, así como a la disminución de los impactos sanitarios, sociales y económicos asociados al consumo.

Se priorizarán investigaciones que aborden modelos de intervención comunitaria, terapias de sustitución o mantenimiento, modelos de dispensación de medicamentos de baja exigencia, dispositivos de RRD y tecnologías para la detección temprana de nuevas sustancias psicoactivas, prevención de sobredosis e intervención oportuna, con enfoques territoriales, comunitarios, de género e interseccionales.

Investigación (I): estudios epidemiológicos, sociales y clínicos sobre consumo de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños.

Desarrollo (D): diseño de modelos de intervención, terapias de sustitución o mantenimiento incluyendo el potencial terapéutico de cannabinoides y dispositivos (fijos y móviles) con énfasis en espacios de consumo de menor riesgo.

Innovación (i): implementación, evaluación y escalamiento de modelos comunitarios de RRD y de tecnologías para la detección temprana de nuevas sustancias psicoactivas, la prevención de sobredosis y el fortalecimiento de respuestas oportunas del sistema de salud.

Experiencia Mínima:

- Experiencia en proyectos de I+D+i en consumo de sustancias psicoactivas o salud mental o reducción de riesgos y daños (RRD).

Av. Calle 26 # 57- 41 / 83 Torre 8 Piso 2 – PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C. Colombia